

Redukcja *unikania agorafobicznego*

Stopniowe wchodzenie w unikane sytuacje — bez zachowań zabezpieczających. Pozostanie uczy, ucieczka wzmacnia lęk.

CZAS: 30–60 min / sesję ekspozycji 4–8 tyg. systematycznej pracy

ŹRÓDŁO: Gloster i wsp. (2011, RCT N=369); Craske i wsp. (2014); Salkovskis i wsp. (1999)

JAK UŻYWAĆ

Stwórz hierarchię unikanych sytuacji od najłatwiejszych do najtrudniejszych (skala 0–100). Zaczynaj od poziomu 30–50. **Wejdź w sytuację na minimum 30 minut** lub do naturalnego końca zadania. Nie skracaj, nie uciekaj, *nie używaj zachowań zabezpieczających*. Powtarzaj z wariacją kontekstu (różne pory, trasy, stany ciała), aż lęk w skali SUDS spadnie do ≤ 20 .

DLACZEGO TO DZIAŁA

Foa i Kozak (1986) — pierwotna teoria habituacji — dominowała do 2000 r. Craske i wsp. (2008, 2014) zrewidowali ją na **uczenie hamujące** (ang. *inhibitory learning*): stare skojarzenie nie znika, ale powstaje konkurencyjne silniejsze. To zmieniło projektowanie ekspozycji — ważniejsze niż redukcja lęku w trakcie jest **naruszenie oczekiwań**. Salkovskis i wsp. (1999): ekspozycja z zabezpieczeniami **nie redukuje lęku** w długim terminie — „przeżyłem/-am bo miałem/-am lek” utrwala przekonanie „bez leku bym nie przeżył/-a”.

01 ✕ Zachowania zabezpieczające — to one trzymają lęk

Każde z poniższych zachowań daje chwilową ulgę, ale **blokuje uczenie** się, że sytuacja jest bezpieczna. Mózg myśli: „przeżyłem/-am bo to robiłem/-am”, zamiast „przeżyłem/-am bo nic nie groziło”. Identyfikuj swoje i usuwaj *stopniowo* — od najłatwiejszego do porzucenia.

Lek w kieszeni „na wszelki wypadek” (alprazolam, lorazepam).

Towarzysz — partner, znajomy, „bo z nim się nie boję”.

Butelka wody, cukierki, „coś do skupienia”.

Sprawdzanie pulsu, ciśnienia, „nasłuchiwanie serca”.

Telefon w rękę z numerem ratunkowym na szybkim wybieraniu.

Siedzenie przy wyjściu — bliżej drzwi, „żeby móc wyjść”.

Unikanie godzin szczytu — tylko poza tłumem, wcześniej rano.

Rozproszenie uwagi — telefon, muzyka, rozmowa „żeby nie myśleć”.

02 ☉ Cztery zasady skutecznej ekspozycji

1 · CZAS + WYTRZYMANIE

Min. **30 min** lub do końca zadania (zakupy, dojazd). Skracanie = utrwalanie. *Lęk zawsze spada sam — pozwól mu.*

2 · BEZ ZABEZPIECZEŃ

Lek w domu, telefon w plecaku, sam/-a. „Przeżyłem/-am bo X” utrwala wiarę, że bez X nie przeżyję.

3 · WARIACJA KONTEKSTU

Różne pory, trasy, stany ciała (zmęczenie, po kawie). Wariacja *uogólnia* uczenie do nowych sytuacji (Craske 2014).

4 · NARUSZENIE OCZEKIWANIA

Zapisz prognozę PRZED, sprawdź po. „Myślałem/-am, że zemdleję — nie zemdlełem/-am” uczy mocniej niż redukcja lęku.

03 Moja hierarchia — od najłatwiejszych do najtrudniejszych

Wypisz **10 unikanych sytuacji**. Dla każdej oceń *przewidywany SUDS* (0–100) i wymień główne zachowania zabezpieczające. Zacznij ekspozycję od pozycji z SUDS 30–50.

#	UNIKANA SYTUACJA <i>konkret, nie ogólnie</i>	SUDS 0–100	ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE <i>co robię w tej sytuacji</i>	DATA WEJŚCIA	SUDS PO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

04 Plan ekspozycji na najbliższy tydzień

POZYCJA Z HIERARCHII

— numer + nazwa

WARIACJE KONTEKSTU

— pory, trasy, stany

ILE RAZY W TYGODNIU

— minimum 3 ekspozycje

ZACHOWANIA, KTÓRE RZUCAM

— 1–2 na początek

Klucz: Gloster i wsp. (2011, randomizowane badanie kliniczne N=369): ekspozycja terapeutyczna *znacząco* skuteczniejsza niż samoekspozycja. Największa pułapka kliniczna: pacjent „wykonuje ekspozycję”, ale z lekiem w kieszeni, telefonem w ręku, partnerem obok. **To nie ekspozycja** — to wycieczka z zabezpieczeniami. Wracaj do listy zachowań zabezpieczających i konfrontuj się z każdym po kolei.